



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مها محمد علي الجيزاوي
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الجيزة
رقم البطاقة : 26406202100168 رقم التليفون : 01154367240
العنوان : الجيزة
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-06-1964 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الصدر بالصبغه [10851] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مها محمد علي الجيزاوي National ID: 26406202100168	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced chest CT

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة لتحقق الشخصية

مها

محمد على الجيزاوى

١٠ من الواووشن المحطه

الجيزه - الجيزه



٢٦٤٠٦٢٠٢١٠٠١٦٨

LD3852620



٢٠٢٥/٠٥ ٢٦٤٠٦٢٠٢١٠٠١٦٨

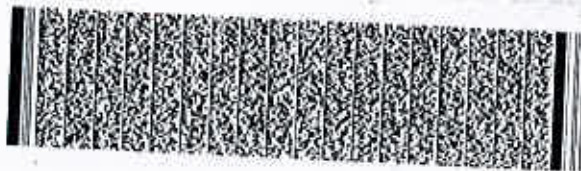
بدون عمل

مستلمة

انثى



البطاقة مدارية حتى ٢٠٢٢/٠٥/٠٤





Patient Name: Maha Mohamed Ali Al Gezawy	Date : 24/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 58 Year(s)
Medical ID:	21627

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Left breast soft tissue lesion.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels, apart from few atheromatous calcifications of the aorta.
- The scanned dorsal vertebrae show no definite lytic or sclerotic lesions.
- Upper abdominal cuts show cholecystectomy clips.

OPINION:

No evidence of pulmonary metastatic disease or pneumonic consolidations or ground glass patches.

Dr. Sherif Sameh, M.D.



Patient Name: Maha Mohamed Ali Al Gezawy	Date : 19/10/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 2488	Pat. ID: 21627

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows LOQ spiculated irregular mass lesion, of high density.
- Complementary ultrasound revealed left breast micro lobulated hypoechoic mass lesion with desmoplastic reaction, with subtle vascularity detected within on color Doppler, seen at 5 o'clock position 9.4mm from the nipple, 1.2mm from the overlying skin, measuring 22 x16mm, consistent to the palpable lump.
- No right solid or cystic mass lesion.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Bilateral nonspecific axillary lymph nodes.

Opinion:

- Left breast LOQ malignant looking mass lesion (BIRADS 4) for histopathological correlation.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Nehal Hamdy

19/10/2022 11:50 AM

21/02/2023, 13:08

code:42 -- Name_A MDT form Harmal -- Name_E MDT form Harmal



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name:

م. محمد علي الهادي

Sex:

MDT form

3- Medical number:

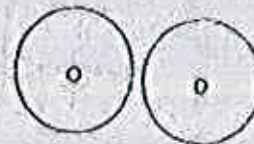
83107036

Old Med:

4518/2022

2-ID number: 26406202100168

Patient Age: 59 Y



Family history

Marital status

Co morbidity

Phone

01154367240 BMI

NRS Score

GROUP

Menopausal status

POSTMENOPAUSAL

REASON OF MDT POST OPERATIVE

Date of MDT

02/21/2023

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup:

CTCAP11/2022-->FREE

BXI

IDC

ER:

7/8

PR:

8/8

Her 2 Neu:

1

SISH:

KI67:

15

LT GIL 11/22

T

2

N

0

M

0

Sonohammography

LT LOQ MASS

NO NIPPLE RETRACTION

NO PALP LNS

PATIENT HISTORY

PATHOLOGY REPORT 25/1/2023-->LT BCS AND SLNB

FREE RESECTED MARGINS,,LN 1/12,,PPR,,STAGE YPT1C YPN1

FOR ADJ TC 4 CYCLES

MDT OUTCOME & PLAN

PORT

ADJ AI

MEDICAL ONCOLOGY

د. اياد شامي
د. هادي صليبي

SIGNATURE

SURGERY

RADIOLOGY

Psychiatric

PATHOLOGY

Nutrition

د. اياد شامي
د. هادي صليبي



Date : 12/09/2023	Patient Name: Maha Mohamed Ali Al Gezawy
Age : 59 Year(s)	Exam : superficial u/s
Pat ID: 21627	Medical ID: 4518/2022

Name: maha Mohamed file : 4518/2022
Date : 12/September 2023

SUPERFICIAL ULTRASONOGRAPHY

Over swelling at the right upper thigh revealed :

- At the site of complaint , there is large inguinal LNs seen with preserved oval shape and hilum, it measures 34x21mm , with cortex= 4 mm
- Normal skin and subcutaneous tissue.
- Normal muscle layers.
- Normal nearby vascular structures.

Conclusions

Right inguinal LNs likely inflammatory.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
12/09/2023 2:25 PM



Patient Name: Maha Mohamed Ali Al Gezawy	Date : 22/11/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 59 Year(s)
Medical ID: 4518/2022	

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C).
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast LOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast LOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative and radiotherapy sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly ,

Dr/Asmaa Zeinhom, Msc



Patient Name	: الأمثلة / مها محمد على الجيزاوي	Request No.	: 13001676
Patient No.	: 26406202100168	Request Date	: 26/11/2022
Path No.	: 3557/22	Verification Date	: 12/12/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Known case of breast cancer with left Indeterminate Intra-mammary lymph node.

Nature of the specimen:

Tru-cut biopsy, collected at 24/11/2022, 3:45 PM.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

• Histological type: Minimally residual lymphoid tissue with Wide Metastatic deposits of breast ductal carcinoma

• Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): II (3+2+1).

• IPT :

ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)

Her-2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+)

Ki 67: 30 % nuclear reaction in tumor cells

Diagnosis:

Known case of breast cancer with left Indeterminate Intra-mammary lymph node; Tru-cut biopsy:

- Wide metastatic deposits of breast duct carcinoma grade II

- ER : Positive (8/8)

-PR : Positive (8/8)

-HER2: Equivocal (score 2+) For SISH .

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 13/12/2022 13:24:04

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed yousse